



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هويدا محمد على محمد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الساحل
رقم البطاقة : 27708180103648 رقم التليفون : 01552095500
العنوان : 0
العمر (تاريخ الميلاد) : 18-08-1977 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هويدا محمد علي محمد National ID: 27708180103648	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Mammography and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

هويـدا
محمد على محمد على
ش احمد رمضان
الساحل - القاهرة

٢٧٧/٠٨/١٨
٢٧٧.٠٨.١٨.٠١.٣٦٤٨

LT1422548

٢٠٢٦/٠٥
٢٧٧.٠٨.١٨.٠١.٣٦٤٨

حاصله على بكالوريوس
معاملات مالية وتجارية
أنشئ
حميدو على إبراهيم بدوي
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٥/٠٢

متزوجة

MDT FORM 18 / 12 / 2025 G

Name	هويرة علي حجاز	MRN	479/28
Age	48 years	ID	CVV.818.1-372
Menopausal status	Perimenopausal	Phone	01552095500
NRS SCORE		Marital status	Married
BMI		Family history	
CO morbidity	-ve	REASON OF MDT	Postoperative

Clinical Data

BX:

ER: 8/8 PR: 7/8 HER 2: +1 Ki67: 25%

Sonomammography:

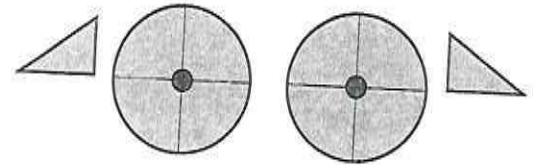
Post NACT
Post Rt MRM

Mets Workup:

Free Deep Margin.
Free Nipple

R

L



TNM 32

Recommendations:

→ Axillary Encl. 10/12

د. الأحمدي
CCO/15/11
Omm
7/12/2025

MDT OUTCOME & PLAN

- ① PORT
- ② Zoladex + AT
- ③ Zometa / 6 months

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Psychiatric

د. محمد حسن / 15/11/2025

Patient Name : الأستاذ / هويدا محمد علي محمد علي
Patient No. : 27708180103648
Path No. : 3553/25
Sex : Female
Age : 48 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003467
Request Date : 18/11/2025
Verification Date : 29/11/2025
Financial Category : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, Post-NACT.
Nature of specimen: Right modified radical mastectomy.

Gross Examination:

- * Right modified radical mastectomy specimen measured 22x14x4 cm, with covering skin ellipse measured 18x10 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
- * Serialing showed a tumor bed site measured 3x3x2.5 cm, located 0.5 cm away from the deep margin.
- * Axilla: Axillary fat measured 8x7x2 cm, entangling 12 lymph nodes, the largest was 1x1x0.5 cm.
- 11 Blocks:
1:6- T.B.S., 7- N&A., 8- Deep margin., 9:11- ALNs.
- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

Microscopic examination:

- * Histological type: Residual viable scattered foci of invasive duct carcinoma (Actual tumor size 3x3 cm) (Cellularity 20%).
- * Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
- * Ductal carcinoma in situ: 80% High grade DCIS (Solid & cribriform patterns with microcalcification).
- * Angioinvasion: Present.
- * Perineural invasion: Absent.
- * Microcalcification: Present.
- * Nipple and areola: Free.
- * Deep margin: Free.
- * Axillary lymph nodes: Positive viable metastatic deposits in ten out of twelve lymph nodes (10/12) (The largest metastatic focus measuring 0.7 cm, with capsular extension).
- * Histologic response to therapy: Pathologic partial response to therapy.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 07/12/2025 13:27:58

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / هويدا محمد على محمد على
Patient No. : 27708180103648
Path No. : 3553/25
Sex : Female
Age : 48 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003467
Request Date : 18/11/2025
Verification Date : 29/11/2025
Financial Category : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis:

- Right breast cancer (Post-NACT), Right modified radical mastectomy:
Residual viable invasive duct carcinoma, Grade 3 (Actual tumor size 3x3 cm) (Cellularity 20%).
- * Ductal carcinoma in situ: 80% High grade DCIS (Solid pattern with microcalcification).
 - * Nipple and areola: Free.
 - * Deep margin: Free.
 - * Axillary lymph nodes: Positive viable metastatic deposits in ten out of twelve lymph nodes (The largest metastatic focus measuring 0.7 cm, with capsular extension).
 - Stage: ypT2, ypN3a.
 - RCB: 3.189, RCB class-II.

Prof. Dr. Maha Guimei.
Dr. Heba El-Shafeey.

Signature

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 07/12/2025 13:27:58

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: هويدا محمد علي
Age / Sex: 48 year / Female
Patient ID: 2126895052

Client Name: -
Referred by Prof: -
Exam Date: 05 Jan 2025
Printed: 1/5/2025 12:31:12 PM

MG

BILATERAL MAMMOGRAPHY:

TECHNIQUE:

- Full field digital mammography in CC and MLO views.
- Mammography tomosynthesis in CC and MLO views (1 mm in thickness).
- **Complementary bilateral breast ultrasound was performed.**

INDICATIONS: Right breast mass

FINDINGS:

- Normal skin thickness of both breasts.
- Breast parenchyma is ACR c, being heterogeneously dense.

RIGHT BREAST:

- An ill-defined density, with two clusters of punctate micro calcification, is noted in the UOQ on mammography, measuring 8.0 x 4.0 cm, in maximum transverse and anteroposterior dimensions, respectively, involving the retro-areolar region. This lesion is detected by ultrasound as an area of architectural distortion, extending from 12 until 9 o'clocks, with an around 2.5 x 2.0 cm, irregular, iso echoic, mildly vascular mass seen amidst, at 10 o'clock, located 3.0 cm from the nipple.
- Multiple pathological axillary levels 1, 2 and 3 lymph nodes are seen, the largest in the former region, measuring 3.0 x 1.5 cm, while that in the latter region, measuring 0.5 x 0.3 cm.
- No pathological supraclavicular or internal mammary lymph nodes detected.

LEFT BREAST:

- No breast masses seen.

Scan Result



00 شارع عبد المنعم رياض، برج الأطباء، الدور ٢
09 شارع شبرا
٦٧ شارع المبرغلي
محطة التعاون
كأينال بيرنس بارك، مبنى ٨٥، الدور ٣
٢٠ شارع الجرائر
٢٢ شارع عبد المنعم رياض

Patient Name: Howaida Mohamed Ali Mohamed Ali	Date : 05/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 479/2025	Pat. ID: 98003

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- Reported case of right breast cancer.
- Compared to pervious CT report dated 27/2/2025, current study revealed:

I Chest:

- Right breast UOQ area of focal asymmetry with mild diffuse skin thickening.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes for sonomammographic assessment.
- Two small right pulmonary nodules the largest is at right lower lung lobe fissural based measuring 4 mm.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.
- Left thyroid gland nodular densities.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenuation. No sizable focal lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Evidence of splenectomy showing no sizable operative bed masses.
- Right adrenal gland fat containing lesion mostly adenoma.
- Normal CT appearance of the pancreas, kidneys and left suprarenals gland.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- No sizable worrisome osseous lesions.

Opinion:

- Reported case of right breast cancer revealed:
- Few right pulmonary nodules for follow up.
- No hepatic deposits.
- No osseous deposits.

Dr. Reda Mabrouk, MD